

前回からきづいたこと→〇〇炎、～～症が多い

実態は身体がエネルギーのコントロールが出来なくなっている状態(生理性を失う)

→多くはエネルギーを入れすぎ

今回のテーマ検査

なぜこの検査なのか？

→重力を基準にしている

→重力は地球上にいる限り絶対に揺るがない基準となるから

人の身体の状態は重力を基準に診断することによって誰がやっても一定の情報が得られる

つまり重力を身体が感作していないとあらゆる不調が現れる

※池江里佳子や宇宙飛行士

感じたイメージ

重力は人が生きる上で絶対に受ける恩恵であり税金のようなもの(逃れられない)

※いっぱい歩く→いっぱい税金払う→福祉などをいっぱい受けれる→健康みたいな

重要

人の脊柱はインバランス構造体

中でバランスを取るような構造体

つまり重力によってこの中でのバランスが崩れる

だから重力を利用した検査方法で身体を観察しなければいけない

さらに、重力を利用して治していかなければいけない

人の非生理を見抜くためには重力の影響から観察するとわかる

関連情報

脳が上にある理由

※参考起立こま

①組成の要因 リポタンパク→油でできている

②比重と還流の要因 油と水では油が上にいくため、また歩行していないと
脳脊髄液の還流が生まれなため認知症や脳機能の低下を引き起こす

心得

検査をするうえで心得ておくこと

×検査はあくまで検査だと思っている

×検査を儀式的作業として考える

×画像所見のほうが徒手検査より優れていると考える

×検査は誰がやっても同じ ※コロナの検査は条件も違うし…

×検査と評価は同じものと思っている

最初はむずいけど最初は重力基準を信じてずっと精度を高めていく

他の検査との違い

検査は生理性がなくてはならない

侵襲性のある検査で害を与えてはならない

※押されるより引かれるほうが10倍以上弱い

※マクマレーや前方引き出しテスト、スパーリングテストなど

整形テストはほぼすべて壊してしまう。

非生理的な検査・施術を排除していく

見るポイント

荷重環境を探る

荷重が両足と脊柱から

それぞれ1:1:1

で荷重がかかると生理的に
機能する

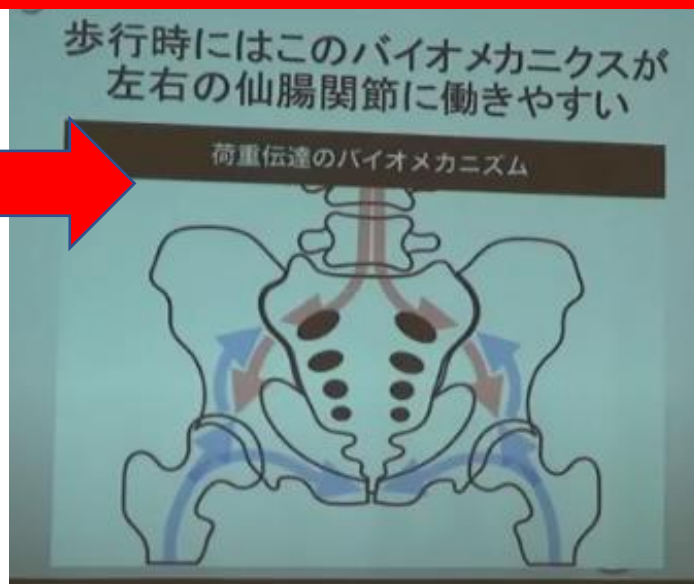


つまり片方ばかりの荷重ため
自転車も

歩行以外で左右均等の過重差を
つくるのは難しい

だから歩かなければいけない

これからどれだけ逸脱しているか検査する



治療よりも患者さんをこの環境を作らせることのほうが大事

人は重力環境下で吊りあいを取りながら生活している

→つまり検査ではこの吊りあいを観察することによってその人の状態を探ろうとしている

バランスとは過不足なく調和のとれた状態をいう

だいたいエネルギー入れすぎだよね↓とか

食べ物、重力荷重、エネルギー

境界層の概念

自分と環境を分けている境目

重力環境がないとこれがわからなくなる→自己免疫疾患とか

この境界層の異常が大きいかどうかを調べる検査としてレバーアームを見ている

つまり検査ポイントWB、B1、B2、B3、B4など移行部が境界層の指標としやすい

重力に対する境界層の変化をみている

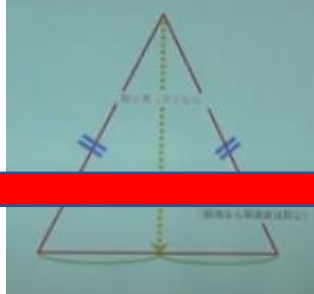
レバーアームとは

支点から
両辺の長さが均等
のとき釣り合う
→レバー発生しない

支点が右へ移動
両辺の長さが変わる
→レバー発生

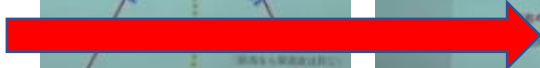
レバー発生なし

レバーアームとは



レバー発生

ずらした軸と境界層で発生した張力の差を
「レバーアーム」がある(発生した)という



インバランス構造体だからバランスを取りあって支点がずれ、レバーが発生する

AIE治療について

『あ』と『い』では喉頭蓋の動きが違う

周波数(振動数)の違いを利用して頸椎に対する治療

これはまた時間があるときにやるとのこと

重力絶対診断7種

7こある

今後核となる検査

精度を高め続ける

誤ったやり方だとすぐに壊す

実は治してもいる

先入観を捨てて検査をする(痛みや病名に左右されない)

難病→あなたの身体は重力対応できていない、それを治すと生理的になるため本来の

人としての機能を取り戻すから良くなっていきますよ患者の身体が病気に打ち勝つ力が育つ

そのための治療だと考える

WBとベース部について

WB→①仙腸関節＋恥骨結合

②足部

③TMJ (顎関節-C3)

※ベース部とWBは重力えお感作する受容器機能が極めて高い部分
固有受容器？

※重力感作する場所を生理的に是正することが臨床の目的

ベース部解説

B1→腰仙移行部

B2→頸胸移行部 上肢帯に影響を大きく及ぼす

B3→胸腰移行部 回旋させる場所 大事だけど他の影響を受けすぎるため指標とするのは、難しい
現在の症状経緯のランドマークとしてみる

B4→頭頸移行部 顔から上にある症状など(目ヤニとか副鼻腔とか)

①前屈テスト

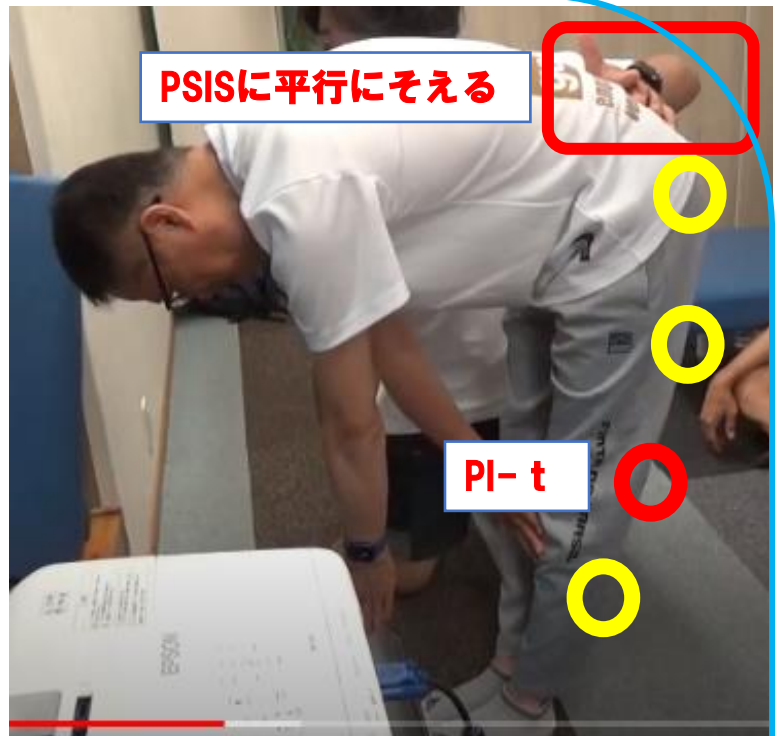
見るポイント

- ① 臀部
- ② ハム
- ③ 膝窩 **ここだけPI-t**
- ④ カーフ

※突っ張るほうとまだ伸びるほう
を聞く

まだ伸びるほうがレバー

わかりにくいときは左右5度ずつあおる



よくある失敗

- 両ひざをついてない
- 足が閉塞立い・両揃えになっていない
- 手の置く位置が平行でない**
- 患者が踵を浮かす
- 痛みがあるのにやる
- 前屈姿勢を維持できる範囲の中で行わない←やわらかい人
- 左右に傾けすぎ

※わかりにくい場合は裏技として5度あおる

※お尻を後ろに突き出すのではなくWBに軸圧をかけて前方にあおる

※まだ伸びそうなのはどこか聞く

※WBのコンパスを倒すように操作する

見解→AS側は正常側と比べて下に下がっているため、テンションがたわみやすいから
正常側が先につっぱりを感じる

判定

- まだ伸びるほうがレバーアーム
- レバー出現は非荷重損傷を意味する
- 膝窩のみPI-t**

※PI-tでは反張膝となる

②後屈 (CP) テスト

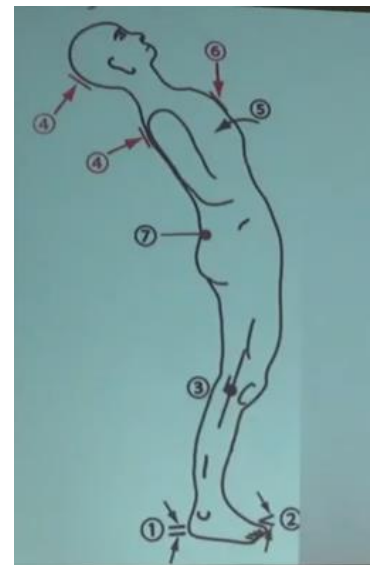
やり方

概要→患者垂直立位で後屈させる

- ①患者気を付けの状態で踵とつま先をあわせて手を胸に当てる
- ②その状態でゆっくり真っすぐ後ろに後屈させる
- ③検査者は患者が回旋動作を入れないか、膝を曲げないか注視
- ④検査者はB2をサポートしながら自分の頭をTh6付近に位置
- ⑤患者は自動運動で後屈させ、ある程度後屈ができたところに頭部挿入
- ⑥検査者は頭を挿入時、患者に捻転させないように注意する

後屈し、PSISに出現するドットの出現をみる

※ドットは圧縮された仙腸関節内外方に発生したレバーの
内側収束形の1つとして限局的に患者が認知するもの



よくある失敗

膝を曲げる

エンドポイントまでいっていない

患者さんが捻転しながら後屈してしまう

術者が胸骨に手を当てる際に地面に水平に圧力かけれない

注意点→患者支点を一定にまっすぐ後屈させる

判定

ドットがあったほうがAS

③B1側屈軸圧テスト

やり方

事前準備としてテンション出現部がどこかを意識するために事前テストをすることが重要
 肩に手を置き重力軸に軸圧をかけていく
 腸骨外翼に出現するレバーアームを助長させていく
 腰に置く手は大転子やや上
 テンション出現部は中脛下線下部、腸骨稜より下7センチあたり

よくある失敗例

身体が捻じれる

足が接地していない→側方動揺じゃない

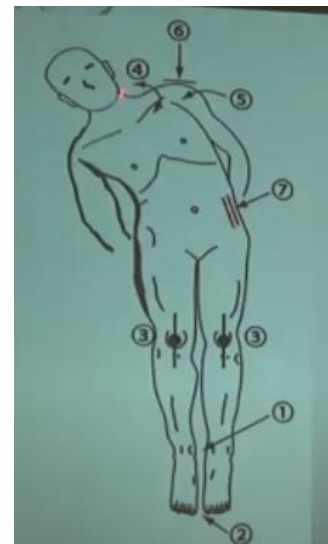
レバー読み取りを腸骨稜より上でみる

大転子直上のレバーをみる

患者の膝がまがる



こちら辺のレバー



判定

テンションがレバーアームの場合、反対側をレバーアームとする

谷崎Dの場合、『L-Be』
 上図の場合、『R-Be』と記載

B2の検査と併用して
 判定する

右PI-t	左PI-t	右AS	左AS
HIP 右Pになりやすい 長母趾 右CGW傾向	左Pになりやすい 左CGW傾向	右Aになりやすい 右弱いor遅い傾向	左Aになりやすい 左弱いor遅い傾向

④B3回旋 (CP) テスト

やり方

足部接地し、座位で回旋

患者胸の前で手をクロスさせる

術者⇒患者の膝を自身の膝で挟み患者の下半身を固定する
一度回旋させ、最大呼気時に片方ずつ回旋テストを行う

注意

患者の脊柱軸は垂直位をキープする

全然動かないときはFIXと記載する→だいぶ悪い

※通常は90～100度回転する

患者を座らせる際に両手を膝におき真っすぐ座らせる

※座骨結節の位置で検査がかわるから

よくある失敗

患者体感軸が後傾する→よく回る

患者体感軸が回旋方向へ傾斜

円背姿勢のおばあちゃんにもピシッと背筋を伸ばしてもらう

理由→曲がったままやるとファセットの離開が起こり壊れてしまう

ポイント→背筋まっすぐ、B3へのコンプレッション

判定

回らない方をB3異常とする

右へ回らない→R-R0

(右ヘローテーションの制限)

※どこを見ているのか→

胸腰椎移行部の回旋を見ているが、
いろんな要因の影響を受ける

例えば腸骨の傾き (PI、AS) で
座骨結節の位置がかわり影響が出る
つまり、仙腸関節の影響も受ける



股関節軸圧テスト (HIPテスト)

潤滑理論の要になるので非常に大事！！

術者患者のポジション取りが大事！

やり方

仰向けにし、一直線上で寝てもらう

痛くて寝れないときはやらない

股関節軽度屈曲位から脛骨粗面を水かきで把持し、仙腸関節にかけて軸圧をややかける

股関節を屈曲し、可動域・抵抗・膝の左右の高低差を見る。その際膝の動作時の軌道を見ることが臨床上大事！！→ASがひどければ外に広がっていく

最大屈曲位の抵抗と可動域をみてから、膝頭を垂直に戻してきた際に抵抗側の左右差をみる

よくある失敗

寝かせ方が患者本位→一直線になってない

寝てから腰をあげていない→骨盤の回旋をとっていない

足を伸展させる際はそーっとやる

股関節をみるから曲げすぎない！→曲げすぎると腰椎の可動域が入る

判定

股関節屈曲位での左右差を見る →左右差基準①抵抗感 ②高低差

	表記	腸骨	読み取れる情報
抵抗側の股関節の膝頭が高い	HIP-A	AS	非荷重があるっぽいかな
抵抗側の股関節の膝頭が低い	HIP-P	PI	PI-tがあるっぽいかな



⑤B2側屈軸圧テスト

やり方

坐骨立ちにて行う

猫背は必ず背筋をまっすぐにしてからおこなう

片側の手を肩鎖関節に置き、もう一方を頬骨に後ろから重力がかからないようそっと差し込む

自動運動で側屈させきってから頸椎へ重力方向に向かってわずかに軸圧をかける

まずデモで患者さんに術者の母指、示指で

倒して軌道を確認させる

大きく傾いている側がレバーアーム側

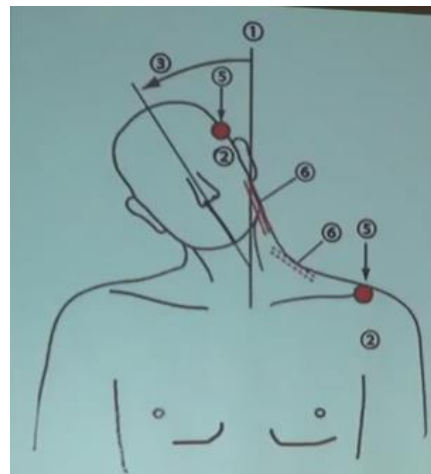
よくある失敗

猫背

頭が前傾

頭が後傾

頬骨を倒してしまう



判定

レバー発生は頸胸移行部異常

右レバー発生→L-Be

※絵の場合 R-Be

この検査はB1の検査と併用して患者さんの診断に用いる



右PI-t

HIP 右Pになりやすい
長母趾 右CGW傾向



左PI-t

左Pになりやすい
左CGW傾向



右AS

右Aになりやすい
右弱いor遅い傾向



左AS

左Aになりやすい
左弱いor遅い傾向

B4軸圧回旋テスト

やり方

姿勢をむっちゃまっすぐにさせる！！

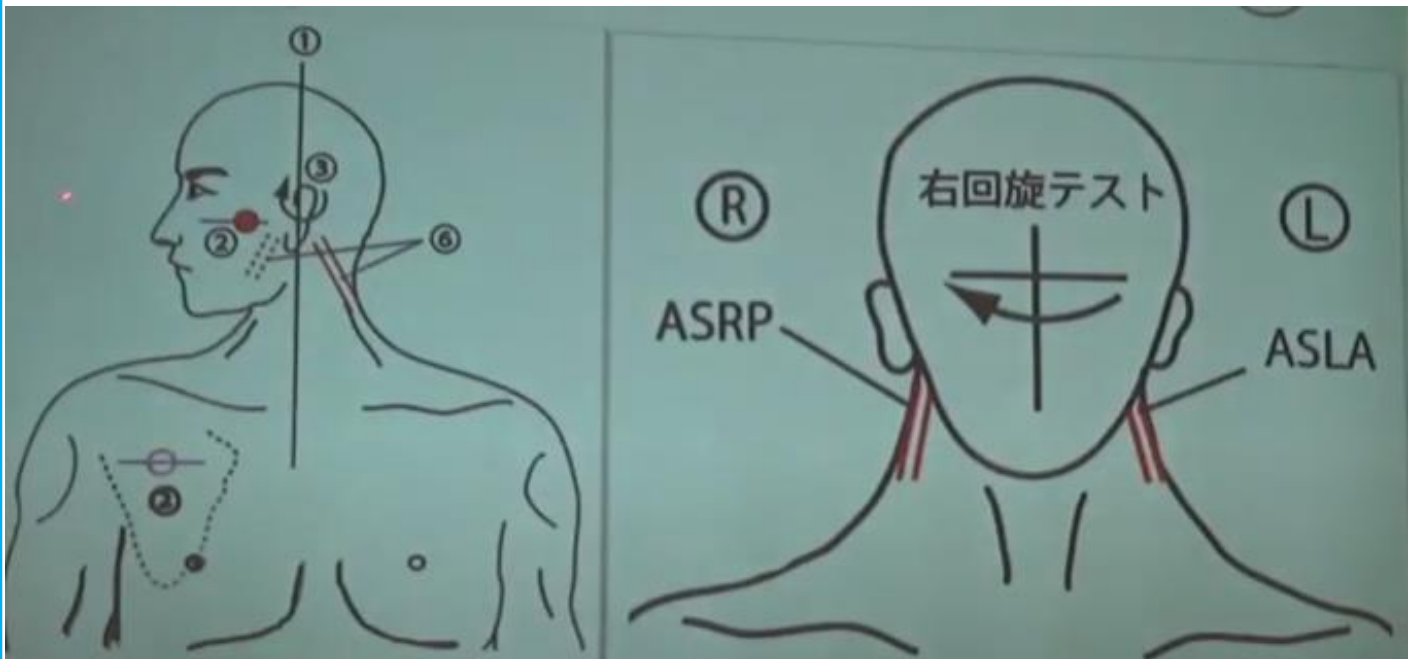
このテストは繊細なため、頭部の前傾や回旋を解除した状態で行わなければならない
座り方もまっすぐ膝をもたせて座らせる

患者自動運動で回旋させ、頭部を左右に回旋させていく

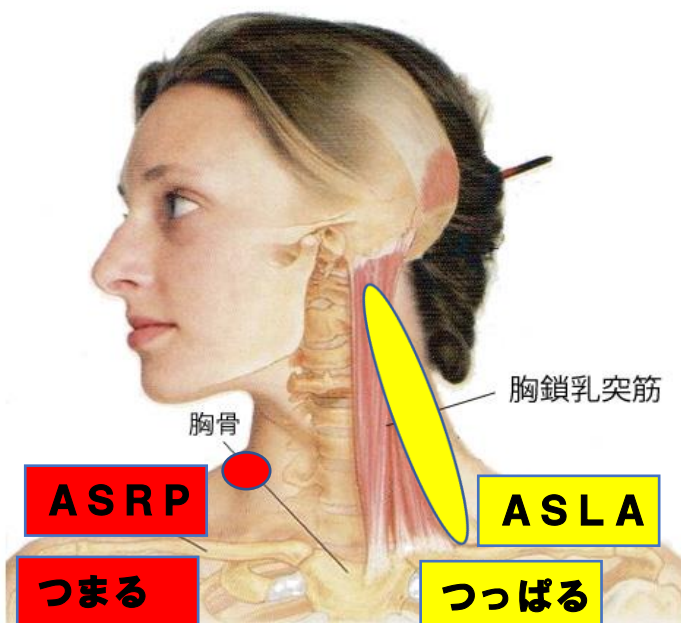
肩甲骨に手を置き、もう一方の手で頬骨に中指を水平に当て水平自動回旋させたあと

重力方向に軸圧をかけてエンドポイントからさらに回旋させる

※この際患者の頭部がぶれないように術者は胸で頭部を支える



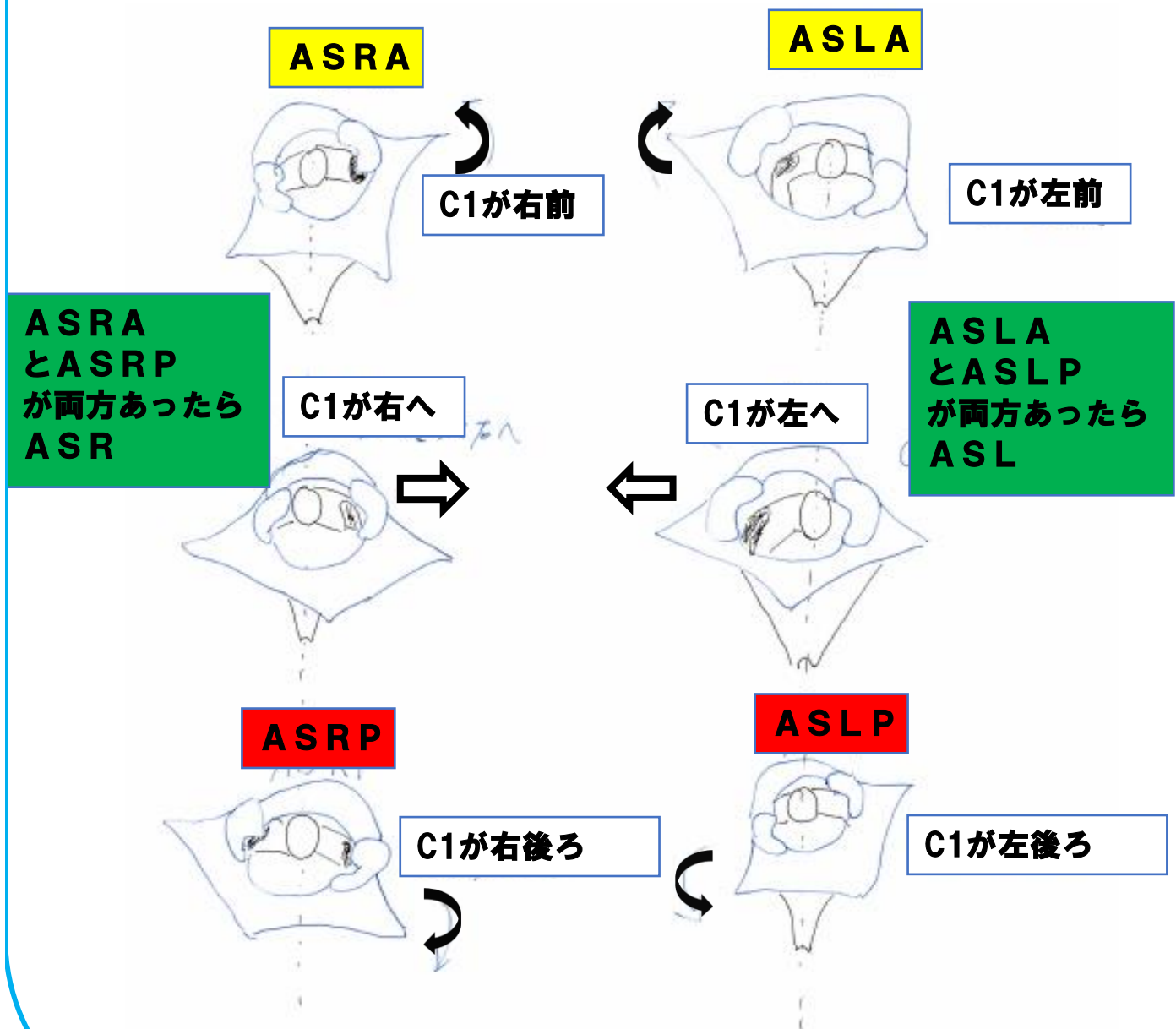
右を向いた場合



左を向いた場合



C1 (アトラス→ASを真上から見た図)



※ASRAやASLAは側屈が入ってしまいやすく誤診も多いため精度を上げる必要がある

重力絶対診断法を使うと見えてくるもの

重力対応＝生命活動 **どれだけ重力に逆らえているか**
ということを理解し、損壊の経緯と回復の道程を理解したうえで
患者さんに説明できるよう精度を磨いていくべし